

大观危机干预技术手册

版本 v1.0 / 2026-06-14

>

来源：希望热线复训课件（PPT + 笔记 + 讲师转录） + 《自我伤害防治心理学》（林昆辉 著）

>

优先级：PPT 课件 = 书籍 > Word 笔记 > 讲师转录

目录

- [第一章 SOR 模型](#第一章-sor-模型)
- [第二章 六大心理连带关系与幸福盘/痛苦盘](#第二章-六大心理连带关系与幸福盘痛苦盘)
- [第三章 人类创伤反应发展模型](#第三章-人类创伤反应发展模型)
- [第四章 生命危机等级表](#第四章-生命危机等级表)
- [第五章 接访流程与时间管理](#第五章-接访流程与时间管理)
- [第六章 六变三托](#第六章-六变三托)

- [第七章 同步同理心技术](#第七章-同步同理心技术)
 - [第八章 倾听与回馈技术](#第八章-倾听与回馈技术)
 - [第九章 R1-R7 接纳技术（动机处理）](#第九章-r1-r7-接纳技术动机处理)
 - [第十章 A-F 六阶段求助等级发展模型](#第十章-a-f-六阶段求助等级发展模型)
 - [第十一章 语言六大因子与搬楼层技术（重度危机干预）](#第十一章-语言六大因子与搬楼层技术重度危机干预)
 - [第十二章 NOPQ 急迫危机干预技术](#第十二章-nopq-急迫危机干预技术)
 - [第十三章 治疗性会谈五阶段模型](#第十三章-治疗性会谈五阶段模型)
 - [第十四章 接线员自我保护](#第十四章-接线员自我保护)
 - [第十五章 常见错误与禁忌](#第十五章-常见错误与禁忌)
-

第一章 SOR 模型

1.1 基本定义

大观学派将人类一切心理活动简化为三个元素：

元素	全称	含义	属性
S	Stimulus（刺激）	客观存在的外部事件	可正、可负、可零
O	Object（认知主体）	个体的认知/诠释系统	决定性的转换器
R	Response（反应）	经由认知加工后的反应	可正、可负、可零

1.2 核心原理

S 的属性不由事件本身决定，而由它穿过 O 之后 R 的表现来决定。

- 经典案例：「好心好意变成驴肝肺」—— 你释放正 S，对方回以负 R。问题在对方的 O（负向认知状态）。
- 客观而言，世上发生的所有事情，就是其该发生的。既然是该发生的，就无所谓正负零。

1.3 治疗意义

- **不能只看 S 或 R，必须看到中间的 O。**
- 处于负 O 状态下的人，无论正 S 还是负 S 穿过，出来全是负 R。
- 治疗的核心不是改变 S，而是干预 O（认知系统）或直接处理 R（行为反应）。
- **自查应用：**为什么你对家人说好话、做好事，对方反应却不好？不是事件问题，是对方 O 状态的问题。

1.4 SOS 热线基本信念

能打电话进来本身，说明案主已具备一定的能力和动力。干预者的任务是**激发其潜能**，而非替代其功能。

第二章 六大心理连带关系与幸福盘/痛苦盘

2.1 六大心理连带关系

这是大观学派对「人何以成为人」的核心框架。贯穿「我」的生命有六条钢索：

连带关系	定义	说明
生命	生死相连，不能独生不能独死	最根本的连带
生理	与自己的身体/性伴侣的关系	身体的健康与存在感
心理	想起对方心里就甜甜的幸福感	情感的归属
生活	日常共处互动的习惯模式	日常的扎根
经济	给/花用钱的关系	物质的安全
社会	社会角色对应关系（夫-妻、父-子等）	角色的确认

2.2 幸福盘

将令人幸福的人、事、物按 **+1 到 +5** 的强度填入六个区，得到六种幸福指数。

幸福盘四大危机：

1. 六大连带关系五个区块都没人
2. 五个区块都是同一个人
3. 五个区块的人都不是家人

4. 觉察后不主动经营，自暴自弃

2.3 痛苦盘

将令人痛苦的人、事、物按 **-1 到 -5** 的强度填入六个区，得到六种创伤指数。

痛苦盘六大危机：

1. 每一种连带关系都受创伤
2. 创伤源都是同一个人/事/理/境
3. 创伤源都是亲人
4. 震央在某一关系，但灾区扩大到多种关系
5. 创伤源不在幸福盘或分数很低
6. 觉察后不主动改变

2.4 治疗应用

- 同一事物可同时在多个维度产生正分和负分。例如：儿子的出生（生命+5），但成绩不好（社会-3）。
- 拉力 = 幸福指数，推力 = 痛苦指数。
- **自杀发生在拉力小于推力时**。关键不在于推力多大，而在于有没有拉力。

第三章 人类创伤反应发展模型

3.1 模型概览

该模型是林昆辉对自杀预防最核心的理论贡献。它将从创伤事件到自杀的全过程分为 **A 到 J 十个阶段**。

核心原则：

- A→J 具有序阶性（层层加深）
- H 阶段（自杀）非常特殊：**A→G 任一阶段都可能直接跳到 H**
- 每一阶段的反应（R）本身可成为下一阶段的刺激（S）
- 治疗就是在这条下坠的路径上找到插入点，逆转方向

3.2 各阶段详解

A（创伤事件）→ B（创伤心理）→ C（创伤生理）→ D（偏差行为）
→ E（人格违常）→ F（精神官能症）→ G（精神分裂症）
→ H（自杀）→ I（自残/自虐）→ J（意外死亡）

A 阶段：创伤事件的反应与刺激

创伤事件的三大种类：

1. 不可能解决的事件
2. 可以解决但资源不足且资源系统已封闭
3. 碰都不能去碰的事件

创伤事件后的五段序阶反应：

阶段	表现	介入策略
否认期	「哪有可能？」	只能催化渡过速度
自怜期	「为什么是我？」	只能催化渡过速度
羔羊期	「谁害的？」	只能催化渡过速度
求助期	「怎么办？」	此时才能提供援助
创伤期	「受不了，不想活了」	需转介心理治疗

关键：前三个阶段（否认、自怜、羔羊）只能陪伴、催化渡过速度，不能给建议。只有到求助期才能提供实质性援助。

B 阶段：创伤心理的反应与刺激

呈现「极端」或「异常」的动机与情绪：

- **极端：**长时间停留在负向状态，但尚可自我控制
- **异常：**越来越长、越来越不能控制、失去对象性、变成强迫性

核心公式：

$$\begin{aligned} \text{心理} &= \text{动机（起心动念）} + \text{情绪（感受）} \\ \text{创伤心理} &= \text{负向动机} + \text{负向情绪（二者必有其一为负向）} \end{aligned}$$

治疗方向：向前看——新的体验产生新的动机和新的情绪，可能替换旧的动机和情绪。

C 阶段：创伤生理的反应与刺激

成人反应	儿童反应
肩颈背酸痛	不动/过动
全身无力/僵直	不食/暴食
胸闷心悸	不语/多语
没胃口	失眠/嗜睡
失眠/嗜睡	尿失禁
性功能障碍	—

创伤生理三阶段：

- 1. 初期：未固化
- 2. 中期：特定生理反应固化，且肌肉筋骨「硬酸痛」不会随心理好转立刻消失
- 3. 末期：脱离因果关联，变成器质性生理疾病

D 阶段：偏差行为的反应与刺激

五种偏差行为：违反礼仪 → 违反常规 → 违反常理 → 违反人情 → 违反法律

介入技术——「指正」而非「指错」：

- 绝口不问是非真假对错
- 直接表达相信对方知道该怎么做
- 相信他有不得已的苦衷
- 帮他拿梯子「下错的台」同时「上对的台」

三大禁忌：

- 1. 不要「指错」

2. 不要做负向的「他人预言」

3. 不要做「人身攻击」

E 阶段：人格违常

与 D 阶段的关键区别：D 阶段自知是非对错；**E 阶段不认为自己错**——「只有需要，没有是非对错」。

五种类型：类分裂型、反社会型、边缘型、做作型、依赖型

F 阶段：精神官能症

- 忧郁症（轻/中/重）：生理症候群 + 心理症候群（什么都不、作息混乱、负向情绪、想死）
- 躁郁症：忧郁 + 狂躁期交替
- 焦虑症：无法控制的担忧与恐惧

重要辨析：关于「重度抑郁症不会自杀」的说法存在争议。课件中标注了对此的质疑。临床上应独立判断。

G 阶段：精神分裂症

失去知觉与表出能力，动机与情绪关联分裂。以精神药物治疗为主。

H 阶段：自杀

自杀方程式 S-R 模型：

S1（事件/心理/行为的冲突困局）+ S2（费尽一切力量都解决不了）
→ R3（自杀动机）
→ S4（撞针事件）
→ R5（自杀行为）/ R6（自残行为）/ R7（自虐行为）

四大自杀行为分类：

- 1. **意外性自杀**：操作前置事件将自己置入险境，然后「意外」死亡
- 2. **动机性自杀**：用肉体痛苦取代心灵痛苦
- 3. **目的性自杀**：把自杀当作生活目的
- 4. **病发性自杀**：病情发作丧失控制能力（以忧郁症最多）

I 阶段：自残/自虐

- **自残**：用濒临致死的行为对抗「想死」的内在威胁，用肉体痛苦替代心理痛苦
- **自虐**：用凌迟肉体的行为惩罚自己「想死」，获得「主宰感」

反直觉理解：自残是「自救」——当事人在用肉体疼痛解除心理疼痛。批评只会让他觉得你更不理解他。

J 阶段：意外死亡

前置事件几乎都是当事人「故意」或「刻意」或「坚持」去做的。放任事件逼成尖锐对立、高度冲突，然后「意外」死亡。

第四章 生命危机等级表

4.1 四级七等 26 级总览

这是大观学派危机干预最核心的诊断工具。从 A 到 Z，26 个等级，对应 7 个等别、4 个危机层级。

4.2 详细分级

第一等：轻度危机——生活事件失控（A-G 级）

核心认知：「干错万错都是别人的错」——没有能力控制环境，归罪于他人、他事、他物。

等级	名称	说明
A	事理不平	外在事件与自己内在「理」不匹配，一切问题的起点
B	人际困扰	—
C	无解决方案	—
D	忧思苦恼	—
E	痛苦绝望	—
F	冷漠	「就这样吧，该咋样就咋样」；视而不见，听而不闻
G	精神困扰	心理和生理都不好（如睡不好导致控制不好情绪）

脱口语：「不想活了」

轻度危机还不会威胁生命，应找亲友谈谈。

第二等：轻度危机——人际冲突挫败（H-J 级）

等级	名称	说明
H	对环境负向观	泛化或灾难化，从环境中抽离，批评否定世界
I	对他人负向观	批评排斥他人
J	对自己负向观	（过去、现在、未来）批评否定自己

第三等：中度危机——异常动机困扰（K-O 级）

核心认知：「千错万错都是自己的错」——特定事件或他人已消失，转而沉沦于自身的负向动机或负向情绪。

等级	名称	说明
K	深度焦虑、恐慌、畏惧、强迫	—
L	对自己/他人/社会的敌意	受害者心态、报复心、想攻击
M	对生命的敌意	「为何没经过我同意就把我生下来」
N	家庭责任瓦解	「家里没我也挺好」
O	生存信念瓦解	不能确认下一秒是否活着

O 级的关键表现：「活一天是一天」的亡命徒心态。「明天、坚持、希望、努力」都失去意义。

第四等：中度危机——异常情绪困扰（P-R 级）

等级	名称	说明
P	重郁、大哭或狂躁	无前置条件
Q1	不快乐	「活不下去了」（被动型）
Q2	活不下去	—
R1	太痛苦了	—
R2	死了算了	「常常想去死」（主动型）

脱口语：「死了算了」

关键辨析：不快乐 ≠ 太痛苦。不快乐常意味着「活不下去」（被动），太痛苦常意味着「想去死」（主动）。

区分轻度和中度危机的关键：有没有前置事件。

- 有具体事件触发 → 常态反应，即使表现严重仍是轻度
- 没有发生任何事但天天想死、天天哭 → 异常，已泛化，进入中度

第五等：重度危机——已启动自杀方程式（S-U 级）

核心认知：不再攻击任何人事物，觉悟「没有能力继续活下去」。

等级	名称	说明
S1/S2/S3	自杀动机（过去/现在/未来）	「因为 S 我才自杀」（有前置事件）
T	自杀意念	「只要是自杀就 OK」（无前置事件）
U	目的性自杀	「只有我自杀了，他们才会……」

付老师类比：自杀动机像「因为家长说考好去旅游所以学习」；自杀意念像「不知道学习有什么用但就是要学习」；目的性自杀像「我学习是为了建设祖国」——工具化程度越深越危险。

第六等：重度危机——准备进入自杀程序（V-W 级）

等级	名称	说明
V1	自伤（自虐、自残、自杀）经验	—
V2	无法制止自杀的处境	—
W1	自杀安排	—
W2	临终安排	—

脱口语：「我要自杀」

需立即找人陪伴，避免独处。

第七等：急迫危机——已进入自杀程序（X-Z 级）

核心认知：觉悟自己没有能力救活自己，出现立刻寻死的语言或行为。

等级	名称	说明
X	立刻去死	现在就自杀的冲动或行为
Y	病发失控	共病失控症状（心率加快、胸闷等）
Z	自杀行为（前/中/后）	正在执行自杀

脱口语：「非死不可」

生命有立即性危险，必须「救下来才能挂断」。

4.3 危机等级诊断方法

四句关键判断句

只能判断「是否在表上」（有无生命危机），不能直接判断级别：

- 1. 「不想活了」
- 2. 「死了算了」
- 3. 「我要自杀」
- 4. 「非死不可」

级别判断的真正依据

不是听他说什么话，而是听「话前面的内容」：

他说的是.....	危机等级
事件（S1 = 没有能力控制事件）	轻度
自己控制不了自己（S2 = 没有能力控制自己）	中度
启动自杀方程（S3 = 没有能力救活自己）	重度
行为已启动（S4 = 没有能力阻止自己）	急迫

反例：他说「不想活了」，但人站在楼顶上马上就要跳——你不能因为他说「不想活了」就评轻度。他是 S4：没有能力阻止自己，是急迫危机。

逐字稿对应法

将来电者的话对应成逐字稿，每说一句就对照生命危机等级表做勾选判断。

动态评估原则

- 危机等级会跳来跳去，不是线性固定的
- **以连续被勾选的最后落脚点（最低最严重的等级）为标准**
- 否则容易高估或低估

案例：来电者说「我以前自杀过」（V1，重度），但当下说的是「爸爸打我凭什么」（A，事理不平，轻度）→ **当下判读是轻度**。不能因为有自杀史就拔高。

「在河边/在天台」≠ 急迫危机

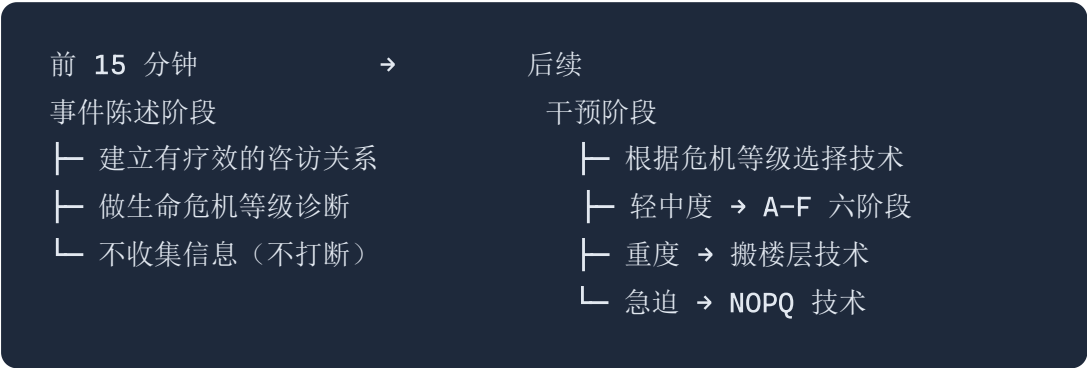
不要仅凭地理位置高危就拔高等级。必须结合言语内容判断。案例：四年级孩子说在十楼窗台上，但谈话内容全是事理不平（父母偏心），无任何关键句 → 连危机个案都不是，是咨询个案。

4.4 危机解除的阳性指标（可观察的降级信号）

1. 小声变大声
2. 被动发言转主动发言
3. 短句变长句
4. 从「怎么死」转向「怎么活」
5. 从「自己」转向「他人或物品」
6. 谈话焦点从「人」转到「事」，从「我」转到「我的」
7. 谈话主题从低等别向上移动（如从 5/6 等升至 3/4/2/1 等）

第五章 接访流程与时间管理

5.1 整体流程



5.2 事件陈述完成的三个标志

1. 案主直接问「怎么办」
2. 案主开始重复讲述
3. 即使 15 分钟还没到，上述两个标志出现即证明陈述可结束

5.3 时间管理标准

危机等级	范围	干预类型	时间限制
轻度 + 中度	A-P	心理咨询	30 分钟内结案
重度	Q-W	降低危机等级	60 分钟内结案
急迫	X-Z	救下来才能挂断	不限时

5.4 信息收集时机

- 前 15 分钟：禁止收集个人信息（年龄、身份等）
- 只能在「谈事」的空档收集

- 案主在谈生死喜怒哀乐时不能打断收集信息
- 目的：保护治疗联盟的建立

第六章 六变三托

6.1 定义

六变三托是识别自杀行为征兆的核心判断工具。来自人类创伤反应发展模型中 R7-R9 级别的关键预警信号。

6.2 六变

序号	名称	具体表现
1	性情大变	外向变内向、内向变外向；少语变多语、多语变少语
2	行为大变	不规律习惯作息，该干嘛不干嘛，不该干嘛去干嘛
3	财务大变	突然处理财务——还债、借钱、把钱送人
4	语言大变	突然谈论或书写与死亡相关的话题
5	身体大变	突然出现与生理疾病不符的身体症状，或突然外表大变
6	环境大变	突然对环境产生巨大变化（搬家、转学、换工作等）

6.3 三托

序号	名称	具体表现
1	托人	突然向亲友嘱咐、要求或委托，加强对某人的照顾
2	托事	突然把自己的重大事件要求或委托代为执行或完成
3	托物	突然打包身边重要文物、玩物或宠物，要求或委托代为照顾或保管

6.4 临床注意

- 「家里的任务都完成了」——老人说这种话是高危信号，在心理层面切断与家的链接
- 「这没我也挺好」——同样逻辑适用于任何人

第七章 同步同理心技术

7.1 定义

同步同理心是前 15 分钟与案主建立有疗效咨访关系的核心技术。

7.2 操作要点

要素	方法	说明
声音三同步	音量、语速、情感跟随案主	案主小声你小声，案主快你快
感叹词	嗯、哦、啊、唉	同一个感叹词不能连用（不能说「嗯嗯嗯」）
连接词	后来呢？接下来呢？	推动陈述
鹦鹉句	重复案主的关键词句	「他说你不行？」
话要比案主少	不插话，不问「为什么」，不问「凭什么」	不能长篇大论

7.3 同步同理心五大效标

案主	接线员
我的事件 → 充分表出	我真心聆听 → 同步表出
我的情绪 → 充分宣泄	我帮忙释放 → 全部承受
我的动机 → 被了解	我充分了解 → 绝对相信
我的行为（反应） → 被允许	我允许认同 → 绝对肯定
不幸的我（人） → 被接受	我完全接受 → 价值见证

7.4 最终目标

建立「CI（案主） — CO（助人者） — 世界」新的连带关系。

7.5 第一句话的禁忌

绝对不能问「我能怎么帮助您」「请您说说您这次接线有什么感觉」——这来自其他流派。

正确开场：「感恩您的信任。」

核心心态：把来电者当作「生死之交」，带着感恩的心接听。

第八章 倾听与回馈技术

8.1 四只好耳朵（倾听技术）

序号	含义
1	我在专心听
2	我听懂你说
3	我赞成你说的
4	我喜欢听你说

8.2 六根好舌头（回馈技术）

回馈针对以下六个层面：

序号	回馈层面	说明
1	对事件回馈	—
2	对情绪回馈	—
3	对动机回馈	—
4	对能力回馈	—
5	对德行回馈	—
6	对团体回馈	—

第九章 R1-R7 接纳技术（动机处理）

9.1 七级递进

从低到高，逐层递进：

层级	名称	核心语言
R1	了解	同步表出，了解案主的动机
R2	接受	不排斥、不否定、不攻击、不回避
R3	肯定	「对你来说是合理的」
R4	认同 (+-)	「我们都会这样想」 / 「虽然我不认同，但对你来说是合理的」
R5	支持 (+-)	「虽然我不支持你，但是对你来说是合理的，好在你说出来没有做」
R6	协助	「我一定要救你」
R7	喜欢	「虽然你的行为有问题，但是我喜欢你」

9.2 使用原则

- 从低层级开始，逐层向上
- 不要跳级
- 每个层级都做到位再往上走
- 不是每次都要走到 R7

第十章 A-F 六阶段求助等级发展模型

10.1 模型概览

这是轻中度危机干预的核心操作流程。**原则：不一定全部走完 A 到 F，根据案主需求灵活运用。到哪算哪。**

10.2 各阶段详解

A — 事件（表出阶段）

项目	内容
案主需要	充分表出
接线员任务	不插嘴、不问缘由、不否定
技术	感叹词 + 连接词（「后来呢」「接下来呢」）+ 鹦鹉句

B — 情绪（宣泄阶段）

项目	内容
案主需要	充分宣泄
接线员任务	完全承接
技术	人称技术

人称技术五级用法：

人称	示例	效果
无人称	「能不生气吗？」	普遍化
第一人称单数	「我听了都生气」	共情
第一人称复数	「我们怎么可能不生气」	联合
第二人称	「难怪你这么生气」	确认感受
第三人称	「他太过分了」	外化

角色扮演技术：当案主需要时，接线员扮演那个对不起她的人，说「对不起，我错了」——这是她在生活中从来没听到过的话。

C — 动机（肯定阶段）

项目	内容
案主需要	被肯定
接线员任务	肯定其动机的合理性，不评判对错
示例	「你当然会这样想啊，怎么可能不这样想。你这样想是合理的」

D — 行为/反应（赦免阶段）

项目	内容
案主需要	被赦免
接线员任务	使用「不得不」的语境
示例	「那种情况下，你也是不得不这样做」

E — 不幸的人（价值见证阶段）

项目	内容
案主需要	被见证
接线员任务	见证其价值与不易
技术名称	「给她戴上痛苦的冠冕」
示例	「这个家老有你，只有你能挺得住。你真是了不起的妈妈」

赞美时机：一定要在案主自己展现出积极面时再赞美。不能在她还在抱怨时就夸。她说「可我还是得管孩子」→「你真是了不起的妈妈」。她说「吃中药不管用还得管孩子」→这时候夸就错了。

F — 我的希望（赋能阶段）

项目	内容
案主需要	被赋能
接线员任务	激发案主自己的办法
核心原则	绝不低估来访者。 激发案主自己想到的办法才是他自己的方法

递进式提问序列：

- 1. 「你喜欢现在的自己吗？」
- 2. 「这样的日子要继续吗？」
- 3. 「真的要改变吗？」
- 4. 「非改不可吗？」
- 5. 「对你来说最重要的是什么？」

- 6. 「为了孩子愿意做点啥？」
- 7. 「要不要先照顾好自己呢？」

整个过程不给建议——「人家能想到的办法人家都知道。」启发案主自己想出来的答案才是他要的。

第十一章 语言六大因子与搬楼层技术（重度危机干预）

11.1 SOR + PNF 语言六大因子

因子	全称	所属空间	含义
S	Stimulus	心理空间	刺激/事件
O	Object	心理空间	认知/诠释
R	Responds	心理空间	反应/回应
P	Past	心理时间	过去
N	Now	心理时间	现在
F	Future	心理时间	未来

11.2 搬楼层技术（核心实战技术）

原理：沿着生命危机等级表，从高往低带。

6 楼（自杀计划 W）→ 5 楼（想自杀 S/T/U）
→ 4 楼（太痛苦了/死了算了 Q1-R2）→ 3 楼（不快乐/活不下去 Q-P）

每层「打扫房间」（用 SOR/PNF 问句清理困扰），然后再「打包换楼层」（用打包问句把案主带到下一个等级）。

11.3 重度危机者特征

- 一般是 O/SO 语言占主导（沉浸在自我诠释中）
- 干预方向：进入他的语言系统 → 增加 SR 语言（具有治愈性的对话）
→ 用打包技术换楼层

11.4 问句序列

第一轮：探索自杀意念历程（从过去→现在）

序号	问句	语言因子	目的
1	「那以前有过这想法吗？」	PO	拉出时间线
2	「第一次有这个自杀的想法是什么时候？」	PS	定位于过去
3	「那时候遇到什么事儿让你有这个想法？」	PSO	探索事件+认知
4	「那个念头出现的时候，你有没有害怕呀？」	PO	探索身心状态
5	「随后又做了什么呢？」	PR	探索行为
6	「那你有跟爸妈说吗？」	PR	探索支持系统
7	「爸爸妈妈的反应是什么？」	—	探索他人反应
8	「那爸爸妈妈这样说，你感觉怎么样呢？」	PSO	探索感受
9	「那时候有这想法时，如何不去自杀的？」	—	找过去的资源
10	「那你成功阻止自杀后，人生有没有什么变化？」	—	确认有活过来的经验
11	「那现在发生了什么事呢？让你冒出这个自杀的念头」	NSR	切入当下
12	「那现在的你如何看待过去引起你自杀的事情呢？」	NOS	从现在的视角看过去

第二轮：打包换楼层

序号	问句	技术要点
1	「从过去到现在有好几次要自杀，这样过日子，你有办法不去死吗？」	打包过去经验
2	「你经历过这么多，太痛苦了，你会不会觉得……」	未完成句 ——让案主自己说出「死了算了」
3	「那你上次觉得『死了算了』又活了过来，那这次有可能再活过来吗？」	双向问句 ——同时包含「活」和「死」
4	「怎么都是要死，你还快乐得起来吗？你一定很……」	未完成句
5	「这样的不快乐会不会哭，会不会叫？」	探索情绪
6	「你会想你的家人吗？」	重建连带
7	「你的家人会想你吗？」	重建连带
8	「不重要多久了？」	量化时间

11.5 关键技术要点

未完成问句：

- 「你会不会觉得不如死了……」 ——停顿，让案主自己说完
- 「不如死了算了」 由案主自己说出来，比接线员说出来强力得多
- 如果案主不说，接线员再说「不如死了」

双向问句：

- 「你觉得这次有可能再活回来吗？」 ——同时包含「活」和「死」两种可能
- 「怎么说都是要死，你快乐的起来吗？」 ——痛苦和快乐对比

面对自杀念头时：

- 立即说「想想就好，想想就好，不做」
- 把「想」和「做」分开
- 不要问他为什么想自杀，不要问原因

找过去的资源：

- 核心问句：「那时你是如何让自己没有去自杀的？」
- 目的是挖掘案主已有的生存策略

11.6 搬楼层三大原则

1. **不能回避谈生死，不能害怕谈生死**——要与案主谈论生与死
2. **核心是组合拳 + 情感**
3. **当案主跟得上谈论较轻等级时，即代表危机等级已减轻一等**

第十二章 NOPQ 急迫危机干预技术

12.1 模型概览

这是针对第七等（急迫危机 X-Z）的专项干预技术。整体流程：

N（承诺救援 + 激发求生意志 + 移动位置 + 询问地址 + 保持通话）
 → 成功 → 做生命等级评估 → 打包往 W → 降低危机等级 → 结案
 → 失败 → O（转接公安局）
 → P（禁止自杀行为）
 → Q（报警）

12.2 N 语言 (N1-N5)

N1：承诺救援

「我要救你，我一定要救你。请你一定要帮我，让我来救你。你一定要给我机会救你，你要帮我，请你一定要帮我。」

- 第一人称 + 第二人称关系句
- 表达坚决的救助意愿

N2：激发求生意志

「一定要活下去，我们都要活下去，你一定要活下去。」

- **三段式重音变化**：重音位置每句不同
- **坚决不去帮他做决定**——不是问「你为什么要自杀」
- 添加情感温度，不能机械念

N3：要求移动位置

「手抓好，移动一下左脚。左脚还是右脚？左脚在里面还是右脚在外面？好，来移动一下。休息一下，靠一下。我一定会救你。」

- N1 和 N2 的真正目的是**制约案主**——在小的事上顺从后，才能要求他做关键行为
- 这是整个 N 语言的核心：**移动到安全位置**

N4：询问地址

「你在哪里？」

N5：保持通话 + 生命等级评估

询问 X/Y/Z：

- **X**：「你现在有没有可能停下来？」——冲动控制
- **Y**：评估共病失控症状（心率加快、胸闷等生理信号）
- **Z**：询问自杀前、中、后的状态

12.3 P 语言（P1-P3）

P1：禁止自杀行为

转移自杀行为。

P2：「改签」技术

不是劝阻自杀，而是改变自杀方式/地点/时间：

类型	话术示例
换地点	「这个地方不好，毛毛的，拜托拜托换个地方」
换方式（跳楼）	「血肉模糊，脑浆迸裂多吓人」
换方式（喝药）	「肠子多难受多烧得慌」
换方式（跳河）	「尸体一泡多恐怖，鱼会吃你」
换时间	「为了我，为了陌生的我，今天不要死。我们生命就连在一起了」

P3：最后的协议

「至少答应我，今天要活着可以吗？」

「我活着，你也得活着，我不许你死。」

「不管别人在不在乎你，我要告诉你，我在乎你。不要你死。」

「为了陌生的我，你也要活下来。」

- 必须果断、坚决、斩钉截铁
- 必须有情感——没有情感就是冷冰冰的文字

12.4 O 语言：转接公安

N 语言一旦失败，转接 O（公安局/警察）。

12.5 Q 语言：报警程序

关键规则：

- 接线员无权直接报警——必须联系当日线上督导，由督导决定
- 单人值班时：必须立即寻求督导协助
- 严禁承诺不报警或不通告家人——这不是接线员能做出的承诺
- 报警话术含工号、地点和具体协助请求
- 报警后必须回拨确认追踪结果

案主拒绝报警时：

「我来就没人接线了，我会让我们相信的人去」

12.6 N 语言重音训练

规则	说明
五个字一个重音	均匀分布强调
最后一个字要转换音色	避免习惯性尾音
复合句重音不在同一位置	每句重音位置不同
前后两句要转换音色	避免单调

12.7 接线要求

- 态度要坚决，不能犹豫
- 不要使用敬语

- 语气果断斩钉截铁

12.8 回拨机制

个案级别	回拨频率	时间窗口
7 级（急迫）	每 4 小时	上午 10:00 - 晚上 10:00
6 级及以下	由督导决定	—

- 7 级个案当下断线：**立即回拨**，不通则报警
- 危机降级后才可调整回拨频率

第十三章 治疗性会谈五阶段模型

这是针对自杀（未遂）个案的完整治疗操作模型。

第一阶段：一般关系之建立（新的、信任的连带关系）

要做	不要做
全时陪伴	不要抱怨、不要质问
生活起居陪伴，不厌烦	—
生活照顾	不要劝善、不要规过
和颜悦色	不要哀求
温言软语	不要责骂
当事人主动诉说时：不插嘴、不问话	—
当事人长时间不说话：不问原因，生活杂谈，增加互动量	—

目标：重新挂上六大连带关系。

第二阶段：治疗关系之建立

1. 见证六大连带关系已破灭
2. 表出模型之抉择见证
3. 负向自我状态的觉察
4. 负向态度的觉察
5. 企求解脱的动机意念的引发与抉择
6. 新的治疗性连带关系的抉择

第三阶段：同步同理心五大阶段

使用同步同理心技术（参见第七章）。

第四阶段：封印旧我、创建新我

摸彩箱与彩球隐喻：

- 人生像一个摸彩箱，别人丢入的黑球（创伤）不会消失
- 但你可以丢入大量红球（积极经验），让摸到黑球的概率变小
- 球已经满了？**封印旧箱，换新箱**

封印的程序：

- 接受（已成为事实）
- 原谅（自己无力回天）
- 不甘心（封印的动力与抉择的勇气）
- 抉择
- 新生

关键：

- 不响应负向循环语言（「为什么我还活着」「我不要活了」等）
- 肯定过去连带关系的经验价值：当事人的所有反应和抉择都是合理的、正常的、必要的、重要的、有价值的

第五阶段：发展新我与六大连带关系价值工程

1. 新旧价值定位与排序（幸福盘与痛苦盘的比较分析）
2. 动机管理：切断负向循环，主动创造与维护高价值「动机-行为-情绪」
3. 低价值「动机-行为-情绪」的主动切除与封印
4. 自我管理：处理善后事件，制定程序
5. 生涯规划作业，制定生活计划表
6. 主动营建新的六大连带关系
7. 家族治疗：调适家庭角色行为与关系

第十四章 接线员自我保护

14.1 入戏与出戏

概念	含义	操作
入戏	通话期间完全扮演接线员角色	放下个人身份
出戏	通话后的自我保护	防止替代性创伤

14.2 高危来电后的处理

- **必须主动联系督导**进行情绪复盘
- 防止耗竭
- 支持结构：背后有 8 名以上线上督导
- 杜老师分享：第一次急迫危机个案 2.5 小时，「浑身是冷的」
- 林昆辉：**「保护接线员比保护案主还重要」**

14.3 报警权限

- 接线员**没有权利**自行报警
 - 必须找当天线上督导请示
 - **严禁承诺不报警或不通告家人**
-

第十五章 常见错误与禁忌

15.1 六大禁忌话术

禁忌类型	错误示例	问题
劝善	「生命是宝贵的」「给自己一个机会」	否定案主的痛苦体验
规过	「你对得起父母吗?」「你怎么可以这样想」	加重罪咎感，加速自杀
哀泣	—	情绪卷入过度
责骂	—	破坏治疗关系
质问	「你凭什么……」	让案主更防御
抱怨	—	丧失中立立场

15.2 其他禁忌

- **严禁自我暴露**：不能说「我以前也这样」「我的孩子也怎样怎样」
- **忌用「聊」「说」**：「我们聊聊」「我们说说」——这是闲聊，不是专业干预
- **同一个感叹词不能连用**：「嗯嗯嗯嗯」让案主感觉你在敷衍
- **不能提前赞美**：赞美必须在 E 阶段（价值见证）且案主已展现积极面时
- **不能给建议**：激发案主自己想出来的才是他的方法
- **前 15 分钟不能收集信息**：打断会破坏联盟建立
- **不能因为地理位置高危就拔高危机等级**：必须结合言语内容
- **如果案主痛苦源是家人，不能说「为了家人」**：适得其反

15.3 新手常见错误清单

1. 接电话第一句就问「我能怎么帮助您」

- 2. 在情绪宣泄阶段过早赞美
- 3. 劝善、劝归、道德说教
- 4. 自我暴露
- 5. 使用「说」「聊」等闲聊词汇
- 6. 感叹词连用或情感错位
- 7. 「好心好意成驴肝肺」——送正 S，收获负 R，不理解为什么（忽略了对方的 O 状态）
- 8. 拉力变推力的识别——长期互动中，曾经的拉力可能变成推力

附录 A：大观心理学派著作体系

著作	方向
《痛苦心理学》	负向心理
《快乐心理学》	正向心理
《家庭心理学》	家庭系统
《小团体心理学》	团体动力学
《自我伤害防治心理学》	自杀预防
《儿童艺术治疗心理学》	儿童治疗

附录 B：危机等级速查表

等	级	核心认知	脱口语	时间	干预
一	A-G	千错万错别人的错	「不想活了」	30min	A-F
二	H-J	泛化负向观	—	30min	A-F
三	K-O	千错万错自己的错（动机）	—	30min	A-F
四	P-R	千错万错自己的错（情绪）	「死了算了」	30min	A-F
五	S-U	没有能力活下去	「我要自杀」	60min	搬楼层
六	V-W	准备进入自杀程序	—	60min	搬楼层
七	X-Z	没有能力阻止自己	「非死不可」	不限	NOPQ

参考来源

>

核心（PPT 课件）：

- 20260516-1 SOR 模型 + 幸福盘 + 痛苦盘 — 付老师

- 20260516-2 生命危机等级表（1） — 付老师

- 20260516-3 急迫危机 + 判断 — 付老师

- 20260517-1 轻中度危机干预技术 — 杜老师

- 20260517-2 重度危机干预技术 — 杜老师

- 20260517-3 急迫危机干预技术 — 杜老师

- 《自我伤害防治心理学》林昆辉 著，电子工业出版社，2015

>

辅助 (Word 笔记 + 讲师转录) :

- 6 份 Word 笔记 (仅急迫危机干预技术笔记有实质新内容)

- 6 份讲师视频转录 (大量临床案例与实操细节)